

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Ұйымның атауы Наименование организации Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан
--	--

Амбулаториялық, стационарлық науқастың медициналық картасынан КӨШІРМЕ
ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 8216
из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Көшірме жіберілген ұйымның атауы мен мекенжайы (название и адрес организации куда направляется выписка)

1. Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество
больного)
- АЛЫБЕКОВ ТЕМИРЛАН РУСЛАНОВИЧ 161021504222
2. Туған күні (Дата рождения)
- 21.10.2016 г.р.
3. Үйінің мекенжайы (Домашний адрес)
- РЕСПУБЛИКА: Казахстан , ОБЛАСТЬ: Алматинская , РАЙОН: Карасайский ,
ГОРОД РАЙ.ЗНАЧ.: Каскелен , УЛИЦА: Сусар , ДОМ: 15
4. Жұмыс орны және лауазымы (Место работы и должность)
- Учащийся
5. Күндері: а) амбулатория бойынша: сырқаттары (Даты: а) по
амбулатории: заболевания)
- 26.07.2024
- б) стационар бойынша: түсуі (по стационару: поступления)
шығуы (выбытия)
- 14.08.2024 09:39
10.09.2024 10:30
6. Толық диагнозы (негізгі ауруы, қосалқы асқынулар) (Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение)
Қорытынды диагноз (заключительный диагноз):
- (Q76.3) Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости
Врожденный сколиоз грудного позвоночника на фоне нарушение формирования позвоночника. Клиновидный Тn9
позвонок. Реберный горб слева. Состояние после коррекции сколиоза с частичной экстирпацией полупозвонка Th9 от
22.07.2019, 2021 г.
7. Қысқаша анамнез, диагностикалық зерттеулер, ауру ағымы, жүргізілген ем, жолданғандағы, шыққандағы жағдайы (Краткий анамнез,
диагностические исследования, течение болезни, проведенное лечение, состояние при направлении, при выписке)

Жалобы при поступлении
Жалобы на боли в грудном отделе позвоночника, наличие деформации.

Анамнез заболевания
Со слов мамы, ребенок более с рождения. Деформацию заметили в возрасте 1 года. После обследования выявлено врожденное аномалия развития позвоночника. Не лечился. В связи с чем 07.06.2019 проконсультирован в НИИТО, ортопедом-вертебрологом Абдалиевым С.С., рекомендовано госпитализация в плановом порядке через портал госпитализации, на оперативное лечение. 22.07.2019 Коррекция деформации позвоночника эндокорректором. Частичная экстерпация Th9 полупозвонка. Задний спондилодез. Послеоперационный период без особенностей. 17.08.2021 Домонтаж эндокорректора спарва, дополнительная коррекция деформации. Данная госпитализация в плановом порядке с целью обследования и определения тактики лечения.

Анамнез жизни
Болезнь Боткина, туберкулез, вен. заболевания отрицает. Со слов на Д-учете у специалистов состоит по поводу основного заболевания.

Аллергологический анамнез
Аллергическую реакцию на лекарственные препараты и пищевые продукты отрицает.

Объективные данные
Общее состояние удовлетворительное. Нормального питания. Кожные покровы, видимые слизистые физиологической окраски, чистые. Дыхание прослушивается по всем полям, везикулярное, хрипов нет, перкуторно – легочный звук. ЧДД 19 в мин. Тоны сердца приглушены. Пульс ритмичный 95 ударов в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Симптом поколачивания отрицателен с обеих сторон. Физиологические оправления в норме. Neurostatus: Контактен. Адекватен. Ориентирован. Зрачки OD=OS, фотореакция живая. Менингеальных знаков нет. Функции тазовых органов не нарушены. Нарушения чувствительности нет.

Статус: При осмотре передвигается самостоятельно, без дополнительных средств опоры. Во фронтальной плоскости определяется деформация верхнегрудном отделе позвоночника с выпуклостью влево. Также определяется асимметрия лопаток, надплечий. Положителен симитом Адамса. Сагитальный баланс сохранен. Старый послеоперационный рубец, состоятелен, без признаков воспаления. При пальпации незначительная болезненность грудном отделе позвоночника, пальпируются концы металлоконструкции.. Сосудистых и неврологических нарушений нет.

Лабораторно-диагностические исследования

Группа крови от 05.08.2024 АВ (IV) четвертая Rh (+) положительный
Биохимия крови от 05.08.2024 Креатинин 58,36, Глюкоза 5,0, Мочевина 5,0, АСТ 26,6, Общий белок 64,5, Билирубин общий 10,7, АЛТ 17,6.

Кал на я/г от 05.08.2024 -отриц.

Микрореакция от 05.08.2024 -отриц.

Общий анализ крови 05.08.2024 лейкоциты 4,6, эритроциты 5,25, гемоглобин 146, тромбоциты 259.

Общий анализ мочи от 05.08.2024 Лейкоциты 0-1, прозрачная, белок отр, плотность 1030, pH5.

Коагулограмма от 05.08.2024 фибриноген 2,2, ТВ 17,79, АЧТВ 22,71, МНО 0,91, ПВ 10,86, ППИ 111,42.

Гепатиты от 05.08.2024 №31719-отриц.

Вич от 07.08.2024 №1001058834-отриц.

Дата завершения заказа: **03.09.2024 05:29 ОАК (3 диф.) на анализаторе** Гемоглобин - 134,6 г/л ; Эритроциты - $4,52 \cdot 10^{12}/л$; Гематокрит - 0,37 L/L ; Средний объем эритроцита - 82,8 фл ; Среднее содержание гемоглобина в эритроците - 29,8 пг ; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците - 360,0 г/л ; Стандартное отклонение объема эритроцитов (SD) - 36,9 фл ; Тромбоциты - $254,6 \cdot 10^9/л$; Распределение тромбоцитов по объему (Анизоцитоз тромбоцитов) - 16,5 фл ; Средний объем тромбоцита - 7,3 фл ; Тромбоцит - 0,185 % ; Лейкоциты - $8,69 \cdot 10^9/л$; Примечание:

Дата завершения заказа: **05.09.2024 06:16 ОАК (3 диф.) на анализаторе** Гемоглобин - 129,9 г/л ; Эритроциты - $4,42 \cdot 10^{12}/л$; Гематокрит - 0,36 L/L ; Средний объем эритроцита - 82,4 фл ; Среднее содержание гемоглобина в эритроците - 29,4 пг ; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците - 357,0 г/л ; Стандартное отклонение объема эритроцитов (SD) - 37,0 фл ; Тромбоциты - $267,7 \cdot 10^9/л$; Распределение тромбоцитов по объему (Анизоцитоз тромбоцитов) - 17,9 фл ; Средний объем тромбоцита - 7,0 фл ; Тромбоцит - 0,188 % ; Лейкоциты - $4,99 \cdot 10^9/л$; Примечание:

Дата завершения заказа: **04.09.2024 06:28 ОАК (3 диф.) на анализаторе** Гемоглобин - 122,8 г/л ; Эритроциты - $4,25 \cdot 10^{12}/л$; Гематокрит - 0,35 L/L ; Средний объем эритроцита - 81,6 фл ; Среднее содержание гемоглобина в эритроците - 28,9 пг ; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците - 354,0 г/л ; Стандартное отклонение объема эритроцитов (SD) - 36,4 фл ; Тромбоциты - $280,0 \cdot 10^9/л$; Распределение тромбоцитов по объему (Анизоцитоз тромбоцитов) - 18,3 фл ; Средний объем тромбоцита - 7,1 фл ; Тромбоцит - 0,199 % ; Лейкоциты - $6,16 \cdot 10^9/л$; Примечание:

Дата завершения заказа: **06.09.2024 11:46 АЛаТ на анализаторе** АЛТ - 18,90 Ед/л ; **АСаТ на анализаторе** АСТ - 26,60 Ед/л ; **Общий Вi на анализаторе** Билирубин (общий) - 5,30 мкмоль/л ; **Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе** Глюкоза (сахар крови) - 5,50 ммоль/л ; **Са на анализаторе** Кальций (общий) - 2,40 мкмоль/л ; **Креатинин на анализаторе** Креатинин - 36,00 мкмоль/л ; **Мочевина на анализаторе** Мочевина - 6,50 ммоль/л ; **Общий белок на анализаторе** Общий белок - 63,30 г/л ; **Ферритин на анализаторе** Ферритин - 77,8 мкг/л ; Примечание:

Дата завершения заказа: **06.09.2024 14:47 ОАМ на анализаторе** Цвет - соломенно-желтый AU/ml ; Прозрачность - прозрачная AU/ml ; Удельный вес - 1,015 AU/ml ; pH - 5,5 AU/ml ; Белок - 0,03 г/л ; Глюкоза - отрицательно mmo/l ; Билирубин - отрицательно mkmol/l ; Уробилиноген - 1,6 mkmol/l ; Кетоны - отрицательно mmo/l ; Лейкоциты - 2-3 в п/зр ; Эритроциты - 0-1 в п/зр ; Аскорбиновая кислота - отрицательно mmo/l ; Нитриты - отрицательно ; **ОАМ** Эпителий плоский - 0 в п/зр ; Эпителий переходный - 0 в п/зр ; Эпителий почечный - 0 в п/зр ; Цилиндры гиалиновые - 0 в п/зр ; Цилиндры восковидные - 0 в п/зр ; Цилиндры зернистые - 0 в п/зр ; Цилиндры лейкоцитарные - 0 в п/зр ; Цилиндры эритроцитарные - 0 в п/зр ; Цилиндры пигментные - 0 в п/зр ; Слизь - нет в п/зр ; Ураты - нет в п/зр ; Оксалаты - нет в п/зр ; Мочевая кислота в моче - 0,0 в п/зр ; Фосфаты - отсутствуют в п/зр ; Трипельфосфаты - нет в п/зр ; Кристаллы мочевой кислоты - нет в п/зр ; Кристаллы холестерина - нет ; Примечание:

Дата завершения заказа: **06.09.2024 12:18 ОАК (5 диф.) на анализаторе** Гемоглобин - 129,3 г/л ; Распределение эритроцитов по объему - 13,8 % ; Эритроциты - $4,61 \cdot 10^{12}/л$; Гематокрит - 0,38 L/L ; Средний объем эритроцита - 81,3 фл ; Среднее содержание гемоглобина в эритроците - 28,0 пг ; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците - 345,0 г/л ; Стандартное отклонение объема эритроцитов (SD) - 37,4 фл ; Тромбоциты - $275,7 \cdot 10^9/л$; Распределение тромбоцитов по объему (Анизоцитоз тромбоцитов) - 18,3 фл ; Средний объем тромбоцита - 7,1 фл ; Тромбоцит - 0,195 % ; Лейкоциты - $5,95 \cdot 10^9/л$; Нейтрофилы (%) - 59,70 % ; Нейтрофилы (абс. кол-во) - $3,55 \cdot 10^9/л$; Эозинофилы - 3,1 % ; Эозинофилы (абс. кол-во) - $0,19 \cdot 10^9/л$; Базофилы - 0,13 % ; Базофилы (абс. кол-во) - $0,01 \cdot 10^9/л$; Моноциты (%) - 7,4 % ; Моноциты (абс. кол-во) - $0,44 \cdot 10^9/л$; Лимфоциты - 29,60 % ; Лимфоциты (абс. кол-во) - $1,76 \cdot 10^9/л$; Содержание незрелых гранулоцитов - 0,90 % ; Содержание незрелых гранулоцитов (абс. кол-во) - 0,05 ; Гипохромные эритроциты - 1,80 % ; Коэффициент микроцитарной анемии - 10,50 ; **СОЭ СОЭ (по Панченкову)** - 27 мм/час ; Примечание:

Дата завершения заказа: **06.09.2024 11:48 ПВ-ПТИ-МНО на анализаторе** Протромбиновое время(сек) - 12,1 сек. ; Протромбиновый индекс - 1,08 ; МНО - 0,96 ; **Фибриноген на анализаторе** Фибриноген - 3,92 г/л ; Примечание:

Дата завершения заказа: **30.08.2024 07:04 ОАК (3 диф.) на анализаторе** Гемоглобин - 141,6 г/л ; Эритроциты - $4,84 \cdot 10^{12}/л$; Гематокрит - 0,40 L/L ; Средний объем эритроцита - 81,8 фл ; Среднее содержание гемоглобина в эритроците - 29,3 пг ; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците - 358,0 г/л ; Стандартное отклонение объема эритроцитов (SD) - 36,9 фл ; Тромбоциты - $266,5 \cdot 10^9/л$; Распределение тромбоцитов по объему (Анизоцитоз тромбоцитов) - 16,9 фл ; Средний объем тромбоцита - 7,5 фл ; Тромбоцит - 0,201 % ; Лейкоциты - $6,05 \cdot 10^9/л$; Примечание:

Дата завершения заказа: **30.08.2024 07:13 ПВ-ПТИ-МНО на анализаторе** Протромбиновое время(сек) - 14,8 сек. ; Протромбиновый индекс - 1,00 ; МНО - 0,95 ; **Фибриноген на анализаторе** Фибриноген - 2,72 г/л ; Примечание:

Дата завершения заказа: **30.08.2024 07:35** **АлаТ на анализаторе** АЛТ - 15,73 Ед/л ; **АСаТ на анализаторе** АСТ - 20,43 Ед/л ; **Общий Вi на анализаторе** Билирубин (общий) - 5,80 мкмоль/л ; **Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе** Глюкоза (сахар крови) - 4,57 ммоль/л ; **Са на анализаторе** Кальций (общий) - - мкмоль/л ; **Креатинин на анализаторе** Креатинин - 63,24 мкмоль/л ; **Мочевина на анализаторе** Мочевина - 6,09 ммоль/л ; **Общий белок на анализаторе** Общий белок - 68,10 г/л ; **Ферритин на анализаторе** Ферритин - 38,4 мкг/л ; Примечание:
Дата завершения заказа: **15.08.2024 12:30** **Антиэритроцитарные антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах (качественный тест)** Антиэритроцитарные антитела - отрицательный ; Примечание:
Дата завершения заказа: **15.08.2024 12:13** **Определение группы крови поликлонами** Группа Крови - АВ(IV) четвертая ; **Определение резус-фактора** Резус-фактор - положительный ; Примечание:

Инструментальные исследования

Обзорная рентгенография органов грудной клетки от 09.08.2024-без патологии.

ЭКГ от 07.08.2024 ритм синусовый с ЧСС 74 в мин, нормальная ЭОС.

Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) (19.08.2024 08:24)

Заключение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:КТ-картина врожденного сколиоза грудного отдела позвоночника. Состояние после оперативного лечения, коррекции сколиоза эндокорректором, частичной экстирпации Th9 полупозвонка слева. Конкресценция C7-Th1-Th2 позвонков справа.

Рентгенография грудного отдела позвоночника (05.09.2024 07:47)

Заключение:

перемонтаж эндокорректора грудного отдела позвоночника

Рентгенография грудного отдела позвоночника (14.08.2024 11:47)

Заключение:

состояние после м/коррекции сколиоза эндокорректором

Консультации специалистов

Консультация: Педиатр (14.08.2024 18:50)

Заключение:

Диагноз: Соматически Здоров. Противопоказаний к оперативному лечению не имеет. врач-педиатр: Курманова Ж.Т.

Консультация: Педиатр (19.08.2024 18:21)

Заключение:

Диагноз: острый ринофарингит, лёгкой степени тяжести. врач-педиатр: Курманова Ж.Т.

Консультация: Реабилитолог (20.08.2024 08:22)

Заключение:

острый ринофарингит, лёгкой степени тяжести. Рекомендации: аэрозольтерапия натрия хлорид 0,9 % раствора №5

Консультация: Педиатр (29.08.2024 18:51)

Заключение:

Диагноз: Соматически Здоров. Абсолютных противопоказаний к оперативному лечению не имеет. врач-педиатр: Курманова Ж.Т.

Консультация: Реабилитолог (03.09.2024 08:08)

Заключение:

Врожденный сколиоз грудного позвоночника на фоне нарушение формирования позвоночника. Клиновидный Th9 позвонок. Реберный горб слева. Состояние после коррекции сколиоза с частичной экстирпацией полупозвонка Th9 от 22.07.2019, 2021 г. Состояние после: (81.05) СПОНДИЛОДЕЗ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКОВ, ЗАДНИЙ ДОСТУП Рекомендовано: аэрозольтерапия 5,0 мл натрия хлорид 0,9 % раствора №1 дыхательная гимнастика №5 кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза №5 Рекомендовано соблюдение ортопедического режима после операции, регулярное выполнение физических упражнений в домашних условиях с целью предупреждения гипотрофии мышц, консультация врача реабилитолога.

Проведенное лечение

Диета: 15 Режим: 3а - свободный

Дәрі-дәрмектерді тағайындау (Назначенные медикаменты):

Анальгин (50% (500 мг/мл), 2 мл, Раствор для инъекций) (2мл Внутримышечно) (1 р/д. 4 д.)

Димедрол (1% (10 мг/мл), 1 мл, Раствор для инъекций) (1мл Внутримышечно) (1 р/д. 4 д.)

Фентанил (0,005% (0,05 мг/мл), 2 мл, Раствор для инъекций) (2мл Внутривенно) (3 р/д. 1 д.)

Польсуксан (100 мг/5 мл, Раствор для инъекций) (5мл Внутривенно) (1 р/д. 1 д.)
Севофлуран (250 мл, Раствор для ингаляционного наркоза) (30мл Ингаляционно) (1 р/д. 1 д.)
Сангера (100 мг/мл, 5 мл, Раствор для инъекций) (5мл Внутривенно (перфузор)) (1 р/д. 1 д.)
Цефуроксим (750 мг, Порошок для приготовления раствора для инъекций) (750мг Внутривенно) (2 р/д. 5 д.)
Ардуан® (4 мг, Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем) (4мг Внутривенно) (1 р/д. 1 д.)
Дипрофол® (10 мг/мл, 20 мл, Эмульсия для инфузий) (20мл Внутривенно) (1 р/д. 1 д.)

Ота кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер (Медикаменты при операции):

Не указано

Орындалған АРИТБ дәрі-дәрмектері (Выполненные медикаменты ОАРИТ):

Натрия хлорид (0,9%, 200 мл, Раствор для инфузий) (200мл Внутривенно) (1 р/д. 1 д.)
Промедол (2% (20 мг/мл), 1 мл, Раствор для инъекций) (20мг Внутривенно) (1 р/д. 1 д.)
Церулин® (0,5% (5 мг/мл), 2 мл, Раствор для инъекций) (2мл Внутривенно) (1 р/д. 1 д.)
Фентанил (0,005% (0,05 мг/мл), 2 мл, Раствор для инъекций) (6мл Внутривенно (перфузор)) (1 р/д. 1 д.)

Состояние пациента: Не указано

Өткізілген трансфузиялар (Проведенные трансфузии):

Не указано

Вакциналау (Вакцинация):

Мед.отвод/Отказ:

Орындалған шаралар (Выполненные процедуры и манипуляции):

Аэрозольтерапия (20.08.2024 08:30)

Заключение:

Аэрозольтерапия (21.08.2024 08:30)

Заклучение:

Аэрозольтерапия (22.08.2024 08:30)

Заклучение:

Аэрозольтерапия (23.08.2024 08:30)

Заклучение:

Аэрозольтерапия (24.08.2024 08:30)

Заклучение:

Аэрозольтерапия (03.09.2024 13:45)

Заклучение:

Дыхательная гимнастика (03.09.2024 13:50)

Заклучение:

Дыхательная гимнастика (04.09.2024 13:50)

Заклучение:

Дыхательная гимнастика (05.09.2024 13:50)

Заклучение:

Дыхательная гимнастика (06.09.2024 13:50)

Заклучение:

Дыхательная гимнастика (07.09.2024 11:24)

Заклучение:

Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза (03.09.2024 13:50)

Заклучение:

Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза (04.09.2024 13:50)

Заклучение:

Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза (05.09.2024 13:50)

Заклучение:

Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза (06.09.2024 13:50)

Заклучение:

Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза (07.09.2024 11:24)

Заключение:

Перевязка (03.09.2024 08:55)

Заключение:

спирт

Перевязка (04.09.2024 08:55)

Заключение:

Перевязка (05.09.2024 08:55)

Заключение:

Перевязка (06.09.2024 08:55)

Заключение:

спирт

Перевязка (07.09.2024 08:55)

Заключение:

сгбhn 70%

Перевязка (08.09.2024 08:55)

Заключение:

спирт 70%

Перевязка ()

Заключение:

Клизма (01.09.2024 22:00)

Заключение:

Операции

81.05 СПОНДИЛОДЕЗ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКОВ, ЗАДНИЙ ДОСТУП

Частичная ламинэктомия Th9. Дополнительная коррекция деформации. Задний спондилодез.

Начало операции: 02.09.2024 09:45

Окончание операции: 02.09.2024 10:35

Длительность операции: 50

Тип анестезии: Комбинированный наркоз

Хирург: АБДАЛИЕВ СЕЙДАЛИ САПАРАЛИЕВИЧ

Анестезиолог: ОСТАНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ассистенты: ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Состояние при выписке

10.09.2024 08:07

Т°:36.6 Пульс:79 АД верх.:100 АД нижн.:70 Дыхание:19 Сатурация:98

Состояние:Удовлетворительное

Совместный осмотр с зав. отд. к.м.н. Абдалиевым С.С.

Общее состояние удовлетворительное. В сознании, контактен. Жалобы на незначительные боли в области послеоперационной раны грудного отдела позвоночника. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски. Дыхание проводится симметрично с обеих сторон, хрипов нет. Сердечная деятельность ритмичная, тоны ясные. Гемодинамика стабильная. Живот мягкий, перистальтика выслушивается.

Локально: пациент передвигается в груднопоясничном корсете. Повязки на послеоперационной ране состоятельны, сухие. Произведена смена асептической повязки. Послеоперационная рана без признаков воспаления, заживает первичным натяжением, швы состоятельны.

Курс лечения закончен. Пациент выписывается для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения. Даны рекомендации.

Исход лечения

Емдеу немен аякгалды (Исход лечения): Улучшение

Лечебные и трудовые рекомендации

1. Наблюдение травматолога – ортопеда по месту жительства.

2. Ношение корсета

3. Курс ЛГ, ЛФК, ФТЛ через 3 месяца

4. Курс консервативного лечения 2 раза в год

5. Санаторно-курортное лечение

6. Ограничение физических нагрузок (поднятия тяжести, прыжки, резкие повороты и наклоны туловища, избегать длительного пребывания в положении сидя).

7. Продолжить перевязки амбулаторно, швы снять после полного заживления раны не ранее 10 суток.

8. Контрольная рентгенограмма через 6 месяцев.

9. Обучение на дому до 3х месяцев.

Үзінді алды (выписку получил):

Бәлім менгерушісі (Зав.отделением) Ф.И.О.

Емдеуші дәрігер (Лечащий врач) Ф.И.О.

АБДАЛИЕВ С. С.

ЩЕРБИНА А. Ю.

подпись

подпись

подпись

Исполнитель : ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ